

# CAT devant un exanthème fébrile

## I. Introduction :

- Exanthème fébrile : éruption cutanée diffuse + fièvre
- Est un motif fréquent de consultations.
- L'orientation diagnostique est basée sur:

\*Analyse sémiologique des lésions élémentaires+++ macule, papule, vésicule, pustule...

\*Contexte épidémiologique+++ Age, contagiosité, collectivité...

On distingue :

- Exanthèmes d'origine infectieuse
- Exanthèmes d'origine non infectieuse : toxique ou médicamenteuse.
- Les exanthèmes fébriles infectieux: étiologies **nombreuses et variées**
- Etiologie souvent **virale+++**  
Mais !
- Etiologie **bactérienne** doit être envisagée engageant le pronostic vital → Des critères de gravité doivent être systématiquement recherchés+++
- LE DÉFI POUR LE PRATICIEN EST DONC:
- Parmi les patients se présentant avec un tel tableau, d'identifier ceux pour lesquels une prise en charge hospitalière et spécialisée en urgence est requise,

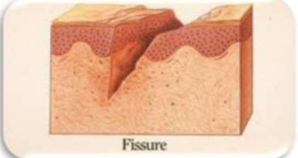
## II. Diagnostic positif :

### A. Confirmer l'exanthème :

Les lésions élémentaires dermatologiques Macule -papule-vésicule-pustule- bulle autres ++++

| Macule                                                                                             | Papule                                                                              | Vésicule                                                                            | Pustule                                                                              | Bulle                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Une tache plate, sans relief de moins de 1 cm.<br>Hyperpigmentée<br>Hypopigmentée<br>Erythémateuse | Elevure cutanée circonscrite de la peau de moins de 1 cm de Q                       | Elevure circonscrite de la peau de Q < 1cm contenant une sérosité claire.           | Semblable à la vésicule et n'en diffère que par son contenu purulent.                | Même caractères que la vésicule mais de taille > 1cm Q.                               |
|                 |  |  |  |  |

Autres lésions :

|        |                                                                                                              |                                                                                     |         |                          |                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nodule | Masse solide de siège hypodermique (plus profonde que la papule) de Q < à 1 cm (nodule si le Q est > à 1 cm. |  | Fissure | Déchirure de l'épiderme. |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                 |                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyste   | Cavité remplie de liquide située dans le derme ou l'hypoderme.  |     | Erosion ou exulcération | Perte partielle intéressant la couche superficielle de la peau (épiderme) ou d'une muqueuse.                                                                                                     |   |
| Croutes | Exsudat desséché sur la peau, se voient au cours de l'impétigo. |    | Ulcération              | Perte totale de l'épithélium de la peau ou de la muqueuse.                                                                                                                                       |  |
| Squames | Lamelles épidermiques détachées de la couche cornée.            |    | Erythème polymorphe     | Image cocarde arrondie bien limitée<br>3 cercles concentriques :<br>- Anneau périphérique érythémateux.<br>- Zone moyenne œdémateuse plus claire.<br>- Centre érythémateux surmonté d'une bulle. |  |
| Tumeur  | Néof ormation cutanée                                           |  |                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

3 types d'exanthèmes :

- Exanthème maculopapuleux.
- Exanthème vésiculopustuleux.
- Exanthème bulleux.

**Il est important de préciser :**

- Importance et l'étendue de l'éruption :

\*nombre d'éléments

\***Séparation** les uns des autres (intervalles de peau saine) ou **confluence** en nappes (sans intervalles de peau saine)

- La topographie : généralisée ou localisée
- Les territoires atteints et préservés : paumes des mains, plantes des pieds, pli de flexion, cuir chevelu,

- Caractère prurigineux ou non
- Modes d'installation, d'extension et de régression
- Présence ou non de desquamation post-éruptive

B. **Caractère fébrile** : confirmer la fièvre et l'objectiver par la prise de la température.

C. **Signes de gravité** :

→ Recherche systématique +++ leur présence permet parfois d'orienter le diagnostic.

1. **Retentissement hémodynamique** :

- **Syndrome de choc toxique** : hypo TA, oligurie, marbrures cutanées...
- **Pronostic vital est mis en jeu +++ urgence+++**
- **Cause bactérienne** : staphylococcique ou streptococcique Toxines++
- **Prise en charge urgente** : réanimation (remplissage, drogues vasopressives, oxygénothérapie) + **antibiothérapie+++**

2. **Erythrodermie** :

- **Atteinte universelle des téguments sans espace de peau saine**
- **Toujours grave ,hospitalisation++**
- **Risques de complications systémiques**
- **Causes**: infectieuse bactérienne staph / non infectieuse :toxidermie ...

3. **Purpura extensif** :

- **Toujours grave méningo+++ (purpura fulminans)**
- **Autres**: sepsis à pneumocoque, à hémophilus/rickettsioses (FBM)/ endocardite

4. **Œdème du visage** :

- **Toujours un signe de gravité dans un contexte d'exanthème +++**
- **Choc anaphylactique /gravité d'une infection**

5. **Décollement cutané : signe de Nicolsky**

- **Signe de Nicolsky**
- **Signe de gravité de toute toxidermie: syndrome de LYELL**

6. **Atteintes viscérales** :

- Insuffisance hépatocellulaire,
- Insuffisance rénale,
- Syndrome méningé,
- Pneumopathie interstitielle,

7. **Hyperéosinophilie** :

- **Taux d'éosinophiles supérieur à 500/mm<sup>3</sup>**
- **Signe de gravité d'une Toxidermie**
- **DRESS syndrome : Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms**
- **Syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse**, survient généralement 2à3 semaines voir plus suivant l'introduction de l'agent causal : **antiépileptiques, sulfamides, allopurinol**
- **Réactivations virales HSV6-7,EBV et CMV**
- **Maladie virale ou le médicament joue un rôle inducteur de réactivation**
- **CLINIQUE** : fièvre + hyperéosinophilie + atteinte viscérale : hépatite, néphrite, pneumonie, péricardite avec risque de défaillance ++
- **TRT** : antiviral +corticothérapie general
- **Ne jamais reprendre le médicament++**



### III. **Diagnostic étiologique** :

A. **L'enquête épidémiologique** :

- **Contexte épidémiologique** :
  - **ATCD de fièvres éruptives**

- ATCD vaccinaux
- Notion de contagé familial ou scolaire
- Voyage récent
- Signes précédents l'éruption et leur durée
- Recherche systématique d'une prise médicamenteuse les jours précédents

## B. Examen clinique minutieux :

- **Analyse de la courbe thermique+++**

Allure, évolution, sa survenue par rapport à la fièvre,

- **Examen des muqueuses** : rechercher un énanthème : conjonctivite, pharyngite, glossite, signe du Koplik, purpura du voile du palais, aphtose,
- Recherche d'adénopathies, d'une angine, d'une hépatosplénomégalie, d'arthrite, de signes digestifs, respiratoires ou méningés..

## C. Les étiologies :

### 1. Exanthèmes maculopapuleux :

#### Origine virale :

#### 1- Rougeole :

- Exanthème maculopapuleux non prurigineux avec des intervalles de peau saines , fébrile dévolution **descendante** en 4 j.
- Virus a ARN **paramyxovirus**.
- **Incubation** : 10-14 j , touche l'enfant entre 3-7 ans et l'adolescent non immunisé.
- **Dg :Epidémiologie-clinique** :
  - \*Notion de contagé, pas de vaccination ou incomplète
  - \*A l'examen : -catarrhe oculo-respiratoire. - signe de **koplik+++**
- **Evolution** :
  - favorable ; apyrexie 3-4 j disparition de l'éruption en 1 s.
  - défavorable ; encéphalite, pneumonie, surinfection (otite, pneumonie... )
- Déclaration obligatoire+++
- **Traitement**:
  - symptomatique.
  - ATB en cas de surinfection bactérienne.
  - VIT A en cas de malnutrition (éviter les lésions oculaires et la cécité).
- Prévention : **vaccination**



#### 2- Rubéole :

- Exanthème maculeux peu érythémateux avec adénopathies cervicales postérieures, arthralgies ,
- Virus à ARN togaviridae.
- Incubation : 14 j en moyenne.
- Evolution : +svt favorable, l'éruption disparaît en 3j
- Les ADP 10 - 14 j après
- Traitement : symptomatique.

#### 3- Exanthème subit (roséole) :

- Exanthème maculopapuleux fébrile **immunisant**, presque obligatoire chez l'enfant **Entre 6mois et 3 ans**.

- Primo-infection par herpes virus humain (HHV6).
- Pas de notion de contagé ni épidémie.
- Evolution :
- Phase pré-éruptive : Fièvre à 39-40°C isolée bien supportée, disparaît en 3 j.
- Phase éruptive : EMP, avec prédominance sur la **nuque** et le **tronc** ne persiste que 12-24 h (peut passer inaperçu)
- Leuco neutropénie est constante.
- Bon pronostic



#### 4- Primo infection VIH :

- Exanthème maculopapuleux
- Touchant le **tronc**, la **face** et le **cou**,
- Se voit dans **60%** des primo-infections symptomatiques.
- Dure en moyenne 10j.
- Autres manifestations : fièvre, arthralgies,
- Dg: PCR : ARN VIH plasmatique /tests sérologiques 4eme génération

#### 5- Primo infection à virus Epstein-barr (EBV) :

- Éruption maculeuse parfois maculopapuleuse
- Se voit dans **5 a 10 %** des cas de mononucléose infectieuse (MNI). **Adulte jeune**
- Constante après la prise d'**Amino-pénicilline**.
- Signes associés : **fièvre, asthénie, angine, SPM**
- Diagnostic : le **syndrome mononucléosique** (c mononucléées:lymT)/cytolyse hépatique, suggèrent le Dg confirmé par la sérologie.
- Trt: symptomatique

#### 6- Autres causes virales :

- **Entérovirus** (écho, coxsackie), adénovirus.
- **Grippe** et infection à **paramyxovirus**.
- **Mégalérythème épidémique** (5eme maladie): parvovirus B19
- **Hépatite B**
- **Arbovirus :**

\*la dengue.

\*chikungunya.

\*le West-Nile

### Origine bactérienne :

#### 1- Scarlatine :

- **Streptocoque du groupe A** (streptococcus pyogenes) +production d'une **exotoxine**,
- Exanthème maculopapuleux **sans intervalle de peau saine**, apparaît au tour de la porte d'entrée avant de se généraliser .
- Dominant aux plis de flexion associer a :
- **Enanthème** : **glossite+++ d'évolution cyclique, desquamation post** éruptive en lambeaux au niveau des extrémités,
- \*T:39-40°C , pouls trop rapide.
- diagnostic : purement clinique.
- Évolution : -guérison spontanée
- -cpc (RAA , endocardite,TSS).

**Scarlatine**



- Trt : peni G , aminopenicilline, macrolide...

## 2- Bactériémie à staphylocoques dorés, streptocoques pyogènes +++/choc toxique :

- Grave ,mise en jeu du pronostic vital +++
- Atteintes multiviscérales de toxines :super Ag:TSST-1( satph)- EXOTOXINES Spe (strep)
- PE : cutanée, tissus mous, gynécologique (tampons,ABRT, post-partum).
- Clinique : sévère++ : fièvre +vmts + diarrhées+ hypoTA+ atteintes multiviscérales + CIVD
- ERYTHRODERMIE suivi de desquamation
- Érythème +œdème des mains+++ /purpura pétéchiale /langue framboisée sont fréquemment observés
- Traitement :
  - o réanimation +++ et antibiothérapie :
  - o Clindamycine inhibe les toxines+++
  - o Associé à l'oxacillne, ou céfazoline staph Associé à la pénicilline G strept
  - o Chirurgie si nécessaire drainage ,nécréctomie

## 3- Rickettsioses : groupe boutonneux :

- FBM :fièvre boutonneuse méditerranéenne
- Rickettsia conorii transmise par la tique du chien rhipicephalus sanguineus
- Éruption cutanée MP constante
- Dg clinique :éruption +escarre d'inoculation ++++
- Trt :doxycycline

## 4- Autres causes bactériennes :

- Tache rosées lenticulaires 10% des FT.
- Brucellose.
- Leptospirose.
- Syphilis secondaire.
- Bactériémie à méningocoque

## Origine parasitaire

- Helminthoses : phase invasive : urticaire et hyperéosinophilie.
- Trypanosomoses.
- Toxoplasmose.

## Origine médicamenteuse

Un certain nombre de toxidermies peut se révéler par un exanthème :

- Bêtalactamines, sulfamides, les AINS, certains antiviraux: abacavir – névirapine
- Interrogatoire++:prise médicamenteuse dans les jours précédents, voir plus jusqu'à 6 mois en cas de DRESS syndrome due à certains anti-arythmiques ou anti- épileptiques
- Tous les type d'éruption peuvent se voir, des le 1er j en cas de sensibilisation antérieure ou plus tardivement (7-10j après l'antibiothérapie :pénicillines+++
- Le prurit, inconstant, a une valeur d'orientation++++
- Les symptômes régressent rapidement à l'arrêt du traitement sauf s'il s'agit d'un produit d'action prolongée (nevirapine, sulfadoxine, sulfadiazine...).

## 2. Exanthèmes vésiculopustuleux :

Origine infectieuse +++ / virale ++++

Les vésicules évoluent en pustules généralement

### 1- Varicelle :

- C'est la principale cause d'exanthème fébrile vésiculeux. Contagieuse +++
- VZV virus a ADN (herpesviridae).
- Incubation 10 a 21 j (moy 14j).
- **Macules** rosées (l'ensemble du corps ++ le visage et le tronc) → **papules** (très prurigineuses) → **vésicules** transparentes (24 h) → troubles → dessèchent → le centre se déprime : croutes
- Eléments d'âge différents +++ et atteinte des muqueuses+++
- Guérison spontanée en 10 a 14j
- cpc:
  - neurologique : ataxie cérébelleuse, encéphalite, polyradiculonévrite, myélite, Méningite, paralysie faciale.
  - surinfections cutanées: AINS ,
  - pneumonie varicelleuse(adulte) formes graves chez l'immunodéprimé
  - autres: laryngite, purpura
  - thrombopénique, déshydratation



### 2- Syndrome mains-pieds-bouche :

- Coxsackie virus A16. Jeune enfant



### 3- Pustulose varioliforme :

- Surinfection des lésions cutanées érosives d'**eczéma** ou de **dermite atopique** par HSV
  - \* eczéma herpeticum\* .
- Lésions **vésiculopustuleuses** du **tronc** dans un contexte de fièvre et d'une polyadénopathie
- **Lésions érosives douloureuses et hémorragiques**,
- Pronostic peut être mis en jeu :surinfections bactériennes-dissémination virale avec
- Atteintes viscérales.



### 4- Autres :

- **Causes bactériennes :**
  - \*pustulose folliculaire:infections du follicule pileux d'origine staphylococcique.
  - \*Bactériémies à staph, méningo, ou gonocoque.
- **Médicamenteuse.**

### 3. Exanthèmes bulleux :

#### 1- Erythème polymorphe :

- Réaction d'hypersensibilité cutanéomuqueuse → lésions bulleuses
- Étiologies : le plus souvent médicamenteuse, chez l'enfant toujours infectieuse+++ causes infectieuses : plusieurs infections virales et bactériennes, les plus incriminées :
- HSV et Mycoplasma Pneumoniae
- Clinique:
  - fièvre + malaise
  - éruption : image en cocarde, 3-4 éléments voir plusieurs dizaines parfois confluentes, érythème : éléments bulleux → ulcérés et douloureux
  - (bouche-zones de jonctions CM : lèvres, orifices nasaux, OGE, marge anale)
- **Evolution** : guérison spontanée : 2 à 3 semaines pour l'érythème polymorphe mineur
- 4 à 3 semaines pour l'érythème polymorphe majeur (signes
- généraux importants et atteinte muqueuse étendue,
- 

#### 2- Toxidermies bulleuses :

- **Les syndromes de LYELL et STEVENS-JOHNSON** :
- Affections aiguës graves
- Destruction : épiderme, épithélium, muqueuses
- Décollements cutanés, signes de Nikolsky positifs :
  - supérieur à 30% pour le syndrome de LYELL
  - inférieur à 10% pour le syndrome de STEVENS-JOHNSON
- Cause : médicamenteuse +++ (sulfamides)



#### 3- Syndrome d'exfoliation généralisée : nécrolyse épidermique par toxine exfoliante staphylococcique

- **Erythrodermie bulleuse et fébrile** + infection staphylococcique muqueuse ou cutanée
- Enfant avant 5 ans
- **Exfoliation** avec décollement de l'épiderme + bulles se déchirent avec érosions épidermiques étendues + atteinte muqueuse : conjonctivite, stomatite.

### IV. Conclusion : points importants

- ❖ Importance d'une analyse sémiologique des lésions élémentaires
- ❖ Recherche de signes de gravité
- ❖ Anamnèse++
- ❖ Recherche de signes extra-dermatologiques à l'examen physique+++
- ❖ Causes infectieuses nombreuses +++
- ❖ Les investigations à visée étiologique dépendent du contexte
- ❖ La prise en charge est fonction de l'étiologie.